

Información Paciente

Nombre : José Hernán Inostroza Jofré
Edad : 77a 3m 13d
Dirección : Batallon Maipo

Rut : 5.686.982-4
Fecha Nacto: 02/10/1948
Comuna : La Pintana

N° Archivo : A437390
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 4220 9749

N° Epicrisis
468861

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Cirugía Sector A - Alta Complejidad
Unidad de Egreso : Cirugía Sector A - Alta Complejidad

Fecha Ingreso : 17/12/2025 01:21
Fecha Egreso : 15/01/2026 11:01

Días Estadía : 29

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Isquemia critica

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiologia

Resumen Clínico

Antecedentes:

Mórbidos: HTA, DM2, EAO, depresión, IC, FA, stent ADA, DHC con hipertensión portal.

Quirúrgicos: Colectomía, apendicetomía.

Fármacos: Losartán, metformina, AAS, carvedilol, atorvastatina, sertralina, espironolactona, insulina.

Alergias: No conocidas.

Historia:

Paciente 77 años múltiples comorbilidades cardiovasculares ingresa 17/12/25 por isquemia crítica EID con úlceras pie derecho. AngioTC ateromatosis severa generalizada oclusión mesentérica superior inferior estenosis 90% tronco celíaco oclusión femoral común derecha estenosis 90% femoral superficial izquierda DHC hipertensión portal. El 22/12 realizan endarterectomía femoral derecha más amputación 4to 5to orjejo, se toma cultivo en donde se aísla SAMR iniciándose vancomicina. El 30/12 sangrado inguinal llevado a pabellón de urgencia, requiere exploración para control sangrado de amputación transmetatarsiana, en recuperación nuevo sangrado, realizan reintervención con resección de parche protésico infectado y reconstrucción de vena safena invertida requiriendo transfusión masiva. Cultivos múltiples reportan KPN KPC BLEE Enterococcus VAN B SAMR E.coli KPC, inicia ceftazidima/avibactam más linezolid 02/01. Ingreso UCI 31/12 shock hemorrágico SAS 1 NAD VMI VAC -75mmHg. Extubación 01/01 apoyo naricera, evoluciona favorablemente, por lo que se traslada a nuestra unidad para continuar manejo. Ingres a UPC con apoyo por naricera 2L/min, manejo optimizado hasta suspensión. En lo hemodinámico evolución favorable sin uso de drogas vasoactivas. En lo quirurgico, con instalación de VAC y recambio el 5/1/2026 con plan de retiro semana siguiente. El Domingo 11/1 durante la tarde presenta aumento de volumen en región inguinal con angioTC compatible con hematoma con signos de sangrado activo sugerente de pseudoaneurisma. Paciente y familiares rechazan inicialmente cirugía de urgencias, difiriendo procedimiento. El 12/01 se conversa en extenso con familiares definiendo intervención paliativa con drenaje hematoma y ligadura arteria femoral común derecha, más cierre cutaneo para permitir drenaje. Impresiona área infectada en región inguinal a la que se toma cultivo, positivo para KPN-KPC BLEE. compatible con infección de herida operatoria con microorganismo de difícil manejo, utilizó tigeciclina como cobertura por 7 días EV: El 13/01 durante la tarde evolución con fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida y compromiso de conciencia, se interpreta como descarga séptica y se sugiere aseo quirurgico de urgencias el 14/01 durante la mañana, se conversa con familiares (Paciente imposibilitado de toma de decisiones por condición) y se define cuidados de fin de vida, dejando BIC morfina confort. El 15/01 durante la mañana presenta paro cardiorrespiratorio, que en concordancia con deseos de paciente previo a complicación) y familiares, se indica orden de no reanimación cardiopulmonar y se constata fallecimiento. Se realiza certificado de defunción.

Fecha Epicrisis : 15/01/2026 11:34

Cultivos:

30/12 (tejido pabellon): (+) E. coli/K. Pneumoneae KPC (+)
30/12 (parche): enterococcus faecium resistente a vancomicina
22/12: (tejido pabellon) SAMR
12/12: (injerto safena): KPN Blee
12/12: (lecho ingle): KPN Blee

Diagnóstico de Egreso

ESTRECHEZ ARTERIAL -
FASCITIS NECROTIZANTE - Región inguinal derecha 2° KPN KPC multirresistente
SEPSIS, NO ESPECIFICADA -

Condición de Egreso

Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente fallece el 15/01/2026 secundario a paro cardiorrespiratorio por shock septico de foco cutaneo en contexto de fascitis necrotizante región inguinal derecha.

Plan Post Alta

Se realiza certificación de defunción.

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles



Vicente Perez Carreño

INTERNO

Becado/Residente

Médico Tratante (Staff)